

Poliitika suuna muutumine Eesti sotsiaalhoolekandes: viimase saja aasta kogemus



Jüri Kõre

Valga vallavalitsuse sotsiaaltöteenistuse juhataja, TÜ sotsiaalpoliitika lektor

Võib-olla kehtivad ka hoolekandes teatavad seaduspärasused, mis mõjutavad arengut ja kitsendavad võimalikke valikuid? Analüüsides Eesti hoolekande arengut viimase saja aasta jooksul jõuame järeldusele, et institutsionaalse hoolekande domineerimisel põhinev arengusuund ilmutab suurt kestlikkust. Poliitika suuna muutmine nõuab uutel alustel toimuvat osapoolte vahelist koostööd.

Sissejuhatus

Vaadates tagasi iseseisva Eesti sajale aastale, on muude edusammude kõrval mõistlik esile tõsta ka hoolekande vallas saavutatut. Ida-Euroopa 20. sajandi hoolekande ajalugu uurinud Sabine Hering (2017) eristab selles nelja perioodi.

- **1900–1918.** Ida-Euroopa on kolme impeeriumi (Preisimaa, Venemaa ja Austria-Ungari) osa, hoolekanne on korraldatud nende impeeriumide reeglite kohaselt. Domineerib eneseabi (perekonna ja kogukonna abi) ja mitteprofessionaalne erahoolekanne.
- **1919–1939.** Eri riikidel on erinev arengutee: nõukogude liiduvabariigid, demokraatlikud süsteemid ja autoritaarsed režiimid, professionaalse sotsiaaltöö algus, avaliku ja erahoolekande põimumine.
- **1939–1989.** Ida-Euroopa on fašismi ja riigisotsialismi haardes, toimub era- ja kirikliku hoolekande radikaalne ümberkujundamine ja asendamine surrogaatidega.

- **Alates 1989.** aastast hüpe riigisotsialismist demokraatlikku kapitalismi, sotsialistliku sotsiaalkaitse ümberkujundamine ja asendamine tasakaalustatud era-avaliku süsteemiga.

Eesti ei osalenud professor Heringu juhitud projektis ja pole teada, kas andmed meie hoolekande ajaloo kohta oleksid väljapakutud skeemi muutnud. Periodiseeringust jääb mulje, et suuresti on tegu liikumisega väljastpoolt paika pandud rööpaid mööda. Samas peab küsima: äkki on Ida-Euroopa hoolekande ajalugu hoopis kindlate hoolekandeparadigmade, mitte impeeriumide ajalugu?

Eesti sotsiaalpoliitika lähtekohaks polnud Vene impeeriumile omane hoolekande käsitus. Tugeva majandusliku alusega omavalitsusvõimu soosinud *semstvoseadus* ei laienenud Balti kubermangudele. Avalik hoolekanne, mida korraldas Vene 1866. a ühiskondliku hoolekande seadus, jäi valla,

linna ja kubermangu hoolekande suhteliselt killustatud seguks. Ülesannete jaotus nende haldustasandite vahel ei olnud eriti selgepiiriline ja hierarhiseeritud. Vene impeeriumilt sai Eesti Vabariik kaasa Bismarcki sotsiaalkindlustussüsteemi: 1912. a tööstusliku töö seadusega oli loodud tööõnnetuskindlustus kaevanduste, tööstuse ja transpordi töötajatele ja samast aastast pärineva haiguskindlustuse seadusega ravikindlustus suurettevõtete töötajatele. Alates 1827. aastast oli pensionide ja ühekordsete hüvitiste seadusega kehtestatud sotsiaalkaitse osas eeliseid pakkuv pensionikorraldus avaliku võimu teenistuses isikutele (sõjaväe- ja tsiviilametnikele). Tsaarivõim ei käsitlenud hoolekannet administreerimise vaatenurgast spetsiifilise tegevusalana, see kuulus siseministeeriumi haldusalasse. Eesti Vabariigi loomisel asutati kohe (1918. aastal) töö- ja hoolekandeministeerium.

Pikavõitu sissejuhatuse kokkuvõtteks peab tunnistama, et Vene impeeriumilt sai Eesti Vabariik perekonna- ja kogukonna vastutusel toimiva hoolekande ja tollastes oludes ainumõeldava tööturu osapoolte vastutusel põhineva sotsiaalkindlustuse süsteemi.

Eesti Vabariik: rõhuasetus institutsionaalsel hoolekandel

1990. aastate esimest poolt kirjeldatakse üleminekuperioodina ja tagasivaates võib sama nimetust kasutada 1920. aastate esimese poole kohta. Neis kahes „alguses” on nii ühis- kui erijooni. Erijoonteks on see, et Vene impeerium tunnetas oma lõpu-aastatel muutuste vajalikkust ja Ajutine Valitsus tegi 1917. a mitmeid korrektiive

sotsiaalkindlustusalastesse seadustesse. Põhiliseks oli sotsiaalkindlustusõiguste laiendamine valdkondade (tööstuste asutamisega alustati tööturupoliitika loomist) ja kontingendi mõttes (kohustusliku kindlustuse piiri alandati 20(30)¹ töötajaga ettevõtetele viie töötajaga ettevõtetele).

Nõukogude impeerium tunnetas küll lääne heaoluriigist lähtuvat ideoloogilist ohtu, kuid suunates ressursse muudesse valdkondadesse, ei suutnud olukorrale adekvaatselt reageerida.

Olles varustatud enam-vähem normaalselt valdkonda ohjavate seadustega, ei tegelenud ei Eesti poliitiline ega majanduslik eliit 1920. aastatel ülevaate innukalt sotsiaalkaitse küsimustega. 1925. aasta hoolekandeseaduse vastuvõtmine oli tolle perioodi suurim saavutus (RT 1925, 120–121). Sellele sammule eelnes üsnagi pingeline poliitiline võitlus parem-vasak skaala vastaspooltes olevate jõudude vahel. Põllumeeste Kogu ja Tööerakonna vaheline vaidlus keskendus eelkõige seadusega riigile tervikuna võetavate kohustuste mahu ja omavalitsustele pandavate ülesannete üle, mida üks pool käsitles ülejookäivate ja ülemäära piiravatena, teine aga sisult ja mahult otstarbekatena. Vasakleer pidas tolleaegset valitsevat vaadet hoolekandele liialt vanamoodsaks ja tegi kogu esimesel iseseisvuse perioodil pingutusi kehtestamiseks üldhoolekannet käsitleva seaduse kõrval eraldi emade ja laste kaitse seadus. Etteruttavalt võib öelda, et 1938. aastaks jõuti vastav eelnõu küll välja töötada, kuid see jäi seaduseks vormistamata. Mõned tollaste vaidluste keskmes olnud teemad (näiteks üksikemade kaitse) on paraku vaieldavad ja rahuldava lahendusest tänase päevani. Minnes tagasi

¹ Ettevõtetes, kus kasutati aurumasinaid, presse vm tol ajal ohtlikke masinaid või seadmeid, hakkas kohustuslik kindlustus kehtima alates 20 töötajast, teistel juhtudel 30 töötajast.

hoolekandeseaduse juurde, tuleb tunnistada, et see võeti vastu hoopis suuremas üksmeeles, kui eelnevad vaidlused oletada lubasid (61 poolt ja 23 vastuhäält).

Millised olid seaduse kohaselt tolleaegse hoolekande rõhuasetused?

- Sugulaste ja omaste abistamis- ja ülalpidamiskohustus säilis, nii nagu ta kehtis Eestis juba kolmveerand sajandit. Väljaspool abielu sündinud lapse isal oli kohustus nii lapse ülalpidamiskulude katmiseks kui ka ema ülalpidamiseks neli nädalat enne ja kuus kuud pärast sünnitamist.
- Eristati riikliku (vastutusala vaimuhai- gused ja lastekaitse), valla, linna, maakonna (vastutusala üldhoolekanne) ja erahoole- kande (sihtühma vaba valik) vastutusalasid.
- Hoolekanne oli segu klassikalisest (vaestehoolekanne) ja tänapäevasest (siht- grupipõhine emade ja laste kaitse) abist. Vaestehoolekannet korraldas omavalitsus. Juhul kui omavalitsuselt abi saanul leiti olevat sugulased, võidi omavalitsuse tehtud kulused kohtu kaudu sisse nõuda. Erandi moodustasid lapsed.
- Eelisarendati institutsionaalset hoole- kannet. Muuhulgas oli töö ja hoolekande- ministriumil ülesanne omavalitsustele hoolekandeaasutuste asutamiseks ettepa- nekute tegemine ja (riigieelarvest) selleks toetussummade taotlemine.
- Esemeline hoolekanne (toiduainete, küttepuude, varjupaiga jms) oli eelistatud abi andmise moodus. Abi saajatel lasus töö- kohustus, sh otsiti jõukohast tööd ka kõigi hoolekandeaasutuste klientidele.

1920.–1930. aastate hoolekande korraldus erines tänasest pildist. Nii nagu tänase päevani on lääneriikides sotsiaalteenuseks lastehoid, nii oli see ka Eesti Vabariigis enne

1940. aastat: 1935/36. õppeaastal tegutses kokku 69 lasteaeda, kus käis 3459 last. Samamoodi hoolitses hoolekanne vaeste raviarvete tasumise eest: 1936/37. aastal tasuti 6419 isiku tervishoiuteenuste kulud. Arvukalt oli institutsioone, mis tegutsesid mitte aasta ringi, vaid hooajaliselt, nt suvised lasteaiad ja mängumurud, kus 1936/37. a viibis 4956 last, ja laste suvekoloniid 1966 lapsega. Seetõttu on avahooldusteenuste ja koduse abi ning institutsionaalsete teenuste arvude võrdlemine tänapäevastega mõne- võrra keeruline. Siiski saab välja lugeda seda, et hoolekandeseaduse vastuvõtmisele järgnenud kümnend oli institutsionaalse hoolekande arendamise periood.

Kavandatud uute institutsioonide (hoole- duskohtade) loomine või olemasolevate laiendamine ei läinud täiesti plaanipäraselt. Kuid vaevalt et on riiki, kus see on 100% õnnestunud. Nii sai ka nõukogude võim „päranduseks” mõned kehvas seisus asutu- sed, mille sulgemist sõjajärgsel kümnendil saatis Eesti Vabariigi riigikorralduse rahva- vaenulikuks kuulutamise retoorika. Et aga nende asutuste näol polnud tegu vabariigi jaoks mingi uhkuse asjaga, tõestab mäng asutuste nimetustega. Nii olid enne sõda kasutusel hoolekandelised ühiskorterid, milles oli kohti kuni 4800 isikule (1936/37. a oli neis tegelikult 3011 klienti). Tegu oli endisaegsete vaestemajade või tänaste varju- paikade tüüpi asutustega, mille klientidelt ei võetud ööbimiskoha eest tasu. Oma muuks ülalpidamiseks vajaliku raha (riide- ja toidu- raha) pidid nad ise muretsema.

Et Eesti hoolekanne ei seisnud sugugi nõrkadel jalgadel, selle tõestuseks toome andmed sotsiaalhoolekande alase hariduse edenemise kohta Euroopas. Kus võima- lik, on toodud ka isiku nimi, keda allikad

Tabel 1. Sotsiaalhoolekande teenuste struktuur ja maht 1920.–1930. aastatel

	Eelarveaasta	
	1928/29	1936/37
Lahtise hoolekande teenuste kasutajaid kokku	40 807	45 957
sh abi kodus	30 305	34 893
Kinnise hoolekande teenuste saajaid kokku	53 300	67 753
Kokku	94 107	113 710

ALLIKAS: EESTI STATISTIKA 1937, 187(6)

nimetavad seoses antud kooli asutamisega. Näeme, et 1935. a Eesti Naisliidu poolt asutatud Kodumajanduse Instituudis 1936. a alanud sotsiaaltöötajate koolitamisega edestas Eesti Soomet. Helsingis algas sotsiaaltöötaja kutset andev õppetöö kaheaastase programmi alusel 1942. Eelkõige lastekodudele mõeldud töötajate koolitamine jätkus ka pärast sõda kuni 1956. aastani Tallinna

Sotsiaal- ja Kodundusinstituudis. Võib-olla on siin sobiv märkida, et USA professionaalsete sotsiaaltöötajate koolitamise algusajaks pakutakse 1904. aastat ja kohaks Bostoni sotsiaaltöötajate kooli. Administreerimise mõttes haldas nõukogude võimu saabudes suuremat osa hoolekandest 1935. a loodud sotsiaalministeerium.

Tabel 2. Professionaalse sotsiaaltöö alase hariduse algus Euroopas

Lääne-Euroopa	Ida-Euroopa	Põhjamaad ja Baltikum
Amsterdam 1899 Berliin 1908, Alice Salomon Birmingham 1908, John Muirhead & William Ashley Viin 1912, Ilse Arlt	Varssavi 1925, Helena Radlinska Budapest 1926, Margit Slachta Bukarest 1929, Princess Ileana Pidev sotsiaaltöö alase hariduse andmine toimus XX sajandil ainult endises Jugoslaavias	Göteborg 1921 (1944) Tallinn 1935 (1936) Helsingi 1942 Riiu 1991, Sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika kõrgkool „Attistiba” Vilnius 1992

ALLIKAS: WIKIPEDIA, THE PROFESSION OF SOCIAL EDUCATION...

Sotsialistlik sotsiaalkaitse: tee proletariaadi diktatuurist homogeensesse ühiskonda

Hüppega 1940. aastast 1944. aastasse „lihtsustame” paratamatult Eesti hoolekande ajalugu. Kuid kuna okupeeritud Eesti alal tegutsenud Eesti Omavalitsuse Sotsiaaldirektooriumi arhivaalid on enamikus hävinud, ei ole allakirjutanul selle perioodi kirjeldamiseks käepäraseid allikaid. 1944. a alustasid tegevust nõukogude võimuorganid, sh järgneva rohkem kui poolsajandi jooksul sotsiaalhoolekande erinevaid osi hallanud hariduse, sotsiaalkindlustuse, tervishoiu ja töö rahvakomissariaat (1947. aastast ministeeriumid).

Sõjajärgsete kümnendite suureks paradoksiks on kindlasti see, et sõja kaotanud riik, Saksamaa, pani sel perioodil aluse oma sotsiaaliigiile (eesmärgiks oli heaolu kõigile). Nõukogude riik kulutas oma ressursse võidurelvastumisele ja paratamatult ei jagunud sellises olukorras raha turvalisuse (veel vähem heaolu) pakkumiseks kogu ühiskonnale. Heaoluriigi asemel ehitati tööriiki. 1940.–60. aastatel oli sotsiaalpoliitika proletariaadi diktatuuri teenistuses (sotsiaalkindlustus palgatöölisele). Selle väite kinnituseks esitame lihtsa näite. Kohe pärast ENSV võimuorganite tegevuse algust 1944. a tollases ENSV „pealinnas” Võrus kehtestas tervishoiu rahvakomissariaat tervishouteenustele hinna. Tasu meditiinteenuste eest pidid maksma kõik, kes ei liigitunud palgatööliseks (käsitöölised, talunikud, nende pereliikmed jne). Järgnevatel kümnenditel, kui palgatöäjõud muutus valitsevaks rakendusvormiks, oli sotsiaalpoliitika korporatiivse elukorralduse teenistuses. Sotsiaalteenuste majandusharu ja ettevõttepõhine korraldus (eluaseme, lastehoiukohtade, tervishoiuteenuste, lastele laagri- ja tööealistele sanatooriumituusikute jaotamine töökollektiivide kaudu) teenisid

töäjõu värbamise ja kinnistamise eesmäärke.

Riikliku majanduse domineerimine välistas abivajaduse korral valiku: hooldamine oli võimalik kas perekonnas või riiklikes hoolekandetasutustes. Balti eraseadusega (1865) kehtestatud ja mõningates detailides perekonnaseaduses (1925), 1940. a kehtima hakanud Vene NFSV ja 1969. a ENSV abielu ja perekonnakoodeksis ning 1995. a ja 2009. a perekonnaseaduses kohendatud **perekonnaliikmete vastastikuse ülalpidamise kohustus on läbi mitme riigikorra jõudnud tänasesse päeva!** Erahoolekanne (sh kiriklik abi) oli ENSVs seadusega keelatud. 1970. aastatel hoolekandekorraldus mitmekesisus. Oma asutusi (lasteaedu, sanatooriume, hooldekodusid) hakkasid looma kooperatiivsed organisatsioonid. Mulje või mälestus tollasest hoolekandest kui valdavalt institutsionaalsest abist püsib tänase päevani ja on pealiskaudsel käsitlusel õige, suurema süüvimise korral aga lihtsustatud. ENSV aastatel tegutses 35–39 hooldekodu, st tegu oli suurte asutustega. Ning nende klientide arv kasvas märkimisväärselt: 3,1 tuhandelt 1940. a 5,1 tuhandeni 1990. a. Samas oleks korrektne eelneva kahe arvu kõrvale panna tänane hoolduslaste arv: üld- ja erihooldekodudes oli 2015. a kokku 10 tuhat inimest. Lastekodudes on vastavate aastate kliendiarvud 2,0, 1,5 ja 1,0 tuhat. Kuid tuleb märkida, et ENSVs polnud nii suuri asutusi, kui oli läänes. Allakirjutanu on ise käinud hoolekandetasutuses, kus oli üle 800 hoolealuse. Tõsi, see arv kujunes erinevaid teenuseid pakkuvate üksuste klientide summana (üldhooldusteenus, dementsusega inimeste hooldus, õendushooldusteenus ja surijate hooldus). **Kuigi ENSVs haldasid hoolekannet ja tervishoidu eri ministeeriumid, mahtusid kaks täna väga rangelt eraldatud teenust, hooldusravi ja hoolekanne, ühte (hoolekande) süsteemi.** 1/3

hooldusasutustest olid kliendi domineeriva teenuse vajaduse mõttes tervishoiu- ja 2/3 hooldusteenuse põhised asutused. Uudsete institutsioonidena alustati 1956. a erineva profiiliga (käitumis-, tervise-, toimetuleku jm probleemidega) inernaatkoolide loomist lastele ja noortele. Esimeseks „pääsukeks” oli 1959. a tööd alustanud Vacküla Internaatkool. Kuna tolleagne lastekaitse oli haridusministeeriumi hallata, ei ole selline areng ootamatu. Ja kui vaatame käesoleval sajandil toimunud täispäevakoolide võidukäigule läänes, siis peame paratamatult küsima: kas 1960. aastatel idablokis alanud pikapäevarühmade ja -koolide levik oli sotsialismile iseloomulik nähtus, või on see hoolekande teatud etapile omane üldtunus? Sotsiaalhoolduse ministeeriumi loomise järel (1978. a) mitmekesisus teenuste pakkumine. Muuhulgas alustati koduhooldusteenuse juurutamisega. Kahes, Tartu ja Pärnu rajoonis, värvati selleks meditsiiniharidusega hooldusõed ning järgneva kümnendi keskel sai 200 eakat meditsiini- ja hooldusabi oma kodus. Eelnevad näited ei ole toodud nõukogude hoolekandekorralduse kiitmise eesmärgil. Eesti Vabariigis domineerinud perekonnasisene abi ja asutushooldus jätkasid ENSVs oma võidukäiku. Nende vahelt „kadus” kogukonna hoolekanne. Paraku oli perekonnastruktuur linnastumise tagajärjel muutunud ja ka inimeste rakendustingimused olid palgatöö valitsemise tõttu varasemaga võrreldes hoopis teised, mis tähendab seda, et perekonna hoolduskoormus, mida laste hooldamise vaatenurgast laste söime ja aegade ehitamisega püüti vähendada, eakate hoolekande

mõttes isegi mõneti kasvas. Ometi tekib küsimus, kas 1980./90. aastatel hinnati eelneva kolmveerandi sajandi hoolekande arengut objektiivselt ja kuivõrd lähtuti muutuste ettevalmistamisel teadmistest ning kuivõrd lihtsustatud hinnangutest.

25 aastat vabadust hoolekandeteenuste pakkumises ja kasutamises

Lõiku viimase veerandi Eesti hoolekande loost tahaks peakirjastada loosungiga „Tööriigist heoluriiki”. Sest vabaduse, demokraatia jms loosungite kõrval on heaolu ootus (võib-olla küll varjatult) olnud sellel perioodil tugev inimesi liikuma panev tegur. Suurimal määral on selle mõju tuntav väljarände dünaamika seletamisel. Üheksakümnendate aastate Eesti sotsiaalkaitse kujundamisel on märgatavad sotsiaalkaitset hällist hauani² lubava Beveridge ettekande³ mõjud. Seejuures on Eesti sotsiaalkaitse administreerimise aluseks Beveridge'i seisukoht, et sotsiaalprobleeme tuleb käsitleda terviklikult (st ühe ministeeriumi kaudu). Täna on brittide arusaamad tublisti muutunud. Nn üldhoolekandega tegeleb Suurbritannias tervishoiu-, lastekaitsega haridus-, perevägivallaga siseministeerium. EV Sotsiaalministeerium püsib vaatamata mõningatele tervishoiu ministeeriumi taastamise katsetele ja trikita mistele abi-, topelt jm ministritega kindlalt edasi.

Kaks kümnendit võitlust vaesusega (1995–2015) on olnud tulemuslik. Tabeli 3 andmed näitavad, et sotsiaalkindlustushüvitiste keskmised suurused on liikunud ühes

² Peapiiskop Temple kasutas terminit *welfare state* (heaoluriik) sõjajärgse Suurbritannia iseloomustamiseks. Termin vastandus tollaste olude kirjeldamiseks käibel olnud mõistele *war state* (sõjas olev riik).

³ William Beveridge'i (hilisem lord Beveridge) 1942. a detsembris avalikustatud „*Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services*”, mis sai sõja järel riikliku sotsiaalkindlustuse ja hoolekande arendamise aluseks.

Tabel 3. Keskmiste palkade, pensionide, abirahade võrdlus toimetulekupiiriga (vaesuspiiriga)

	2006 (eurot)	Võrdlus vaesus- piiriga 2006 (kordi)	2016 (eurot)	Võrdlus vaesus- piiriga 2016 (kordi)
Keskmine palk	363	3,09	924	4,62
Alampalk	158,5	1,35	430	2,15

ALLIKAS: STATISTIKAAMET, EV SOTSIAALMINISTEERIUM

rütmis palkadega. Ja **2015. aastal on ka kõige madalama keskmise tasemega toetuse määr ületanud toimetuleku(vaesus) piiri**. Mõnelgi juhul ei otsita Eesti heaolupoliitikas täna enam ühisjooni ei preisi, ei briti, vaid hoopis Skandinaavia maade sotsiaalkaitsega. Paraku on tegu ikka sellesama Vene tsaaririigilt päranduseks saadud Bismarcki sotsiaalkindlustusega. Arvesse võttes, et nimetatud sotsiaalpoliitika mudel elas üle II maailmasõja, kahe Saksamaa ühinemise, 2015. a põgenikekriisi jpm, on tal piisav tugevusvaru.

Mis asjaolud jäid veerand sajandit tagasi arvesse võtmata, et hoolekandekorralduses valitud tee ei viinud soovitud paindliku, jätkusuutliku, humanistliku süsteemi loomiseni?

Sotsiaalkindlustusest hoopis keerulisem on hinnata hoolekandekorralduse hetke seis. Päris mitmest riiklikust strateegiast leiab terminid „deinstitutionaliseerimine” ja „kogukonna hoolekanne”. Mõlema mõiste ümber on piisavalt poleemikat nende täpsema tähenduse üle. Õnneks ei esitata vastuväiteid üldise arengusuuna kohta, mida need kirjeldavad. Tegelikult korratakse 1980.–1990. aastate vahetusel aktuaalseid mõtteid: soovi tuua puuetega

inimesed koduseinte vahelt kogukonda; saavutada professionaalsete hooldustöötajate abiga kõrgemat hoolduse kvaliteeti perekonnas hooldatavatele eakatele; abivahendeid, kohandusi jms, mis võimaldaksid üksikul inimesel väikese kõrvalabiga iseseisvalt hakkama saada jne. Tollased ideed ja taotlused ei ole täiel määral teostunud. Veerandsajandiga kahekordseks kasvanud institutsionaalse hooldusteenuse mahtu saab osaliselt põhjendada eakate arvu kasvuga. Vahemikus 1990–2015. a on 85aastaste ja vanemate rühm suurenenud 1,8 korda. Kuid see muutus aitab ainult osaliselt seletada olemaolevat teenuste dünaamikat. Sealjuures puudub tuntav soov analüüsida, mis asjaolud jäid veerand sajandit tagasi arvesse võtmata, et hoolekandekorralduses valitud tee ei viinud soovitud paindliku, jätkusuutliku, humanistliku süsteemi loomiseni.

Kokkuvõtte

Võib-olla kehtivad ka hoolekandes teatavad seaduspärasused, mis mõjutavad arengut ja kitsendavad võimalikke valikuid? Ja poliitika suuna muutmine on võimalik kas kriiside kaudu või teadliku tegevuse tulemusel olukorras, kui avaneb võimaluste aken (poliitikud on nõus erialaselt soovitatavate muutustega) vms.

Pea sajandi pikkune institutsionaalse hoolekande domineerimisel baseerunud arengusuund ilmutab suurt kestlikkust ning

poliitika suuna muutmine nõuab hoopis teistsugustel alustel toimuvat osapoolte vahelist koostööd, kui meil praktiseeritakse arengukavade või strateegiade vormistamisel. Võib olla tasub nii nagu veerand sajandit tagasi, uuesti kiigata brittide poole. Nende käimasoleva sotsiaalhoolekande reformi rohelises raamatus uue süsteemi alustena

nimetatavad seitse kuldset sammast tunduvad olevat üsna toekad: 1) kvaliteet; 2) inimest terviklikult käsitlev integreeritud abi; 3) kontroll; 4) tööjõud; 5) perede ja omastehooldajate toetamine; 6) sotsiaalkaitse jätkusuutliku rahastamise mudel, mida toetab mitmekesine, elav ja stabiilne turg; 7) turvalisus kõigile (Hunt 2018). 

Viidatud allikad

- Hering, S.** (2017). Comparing East and West – a flashback on the history of comparative research in social work. *European Journal of Social Work*, 20: 6, 801–810.
- Hoolekande seadus.** Riigi Teataja, nr. 120–121, 17. juuli 1925.
<https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=AKriigiteataja19250717.2.3> (21.11.2018).
- Hoolekandeseadus: ühes hoolekande alasse puutuvate määrustega, juhtnööridega ning seletustega.** (1938). Koostaja E. Mailand.
- Tuisk, A.** (1937). Lastekaitse ja hoolekanne. *Eesti Statistika*, 187(6).
- Leppik, E.** (1994) *Eesti hoolekande ajaloolisi arenguhooni. Raamatus: Eesti sotsiaaltöö küsimusi: teadusartiklite kogumik*, 1, 73–88.
- Eestis vajab hoolekandelist abi 35.000 kodanikku** (1939). *Postimees*, 34, 4 veebruar.
<https://dea.digar.ee/article/postimeesew/1939/02/04/5>. (21.11.2018).
- Siigur, H.** (1961). NSV Liidu riigikulud riiklikule sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalhooldusele. Tartu Riiklik Ülikool.
- The profession of Social Education in Europe.** Comparative survey. (2011) AIEJI. <http://aieji.net/wp-content/uploads/2010/11/The-Profession-of-Social-Education.pdf>. (21.11.2018).
- Hunt, J.** 20 March 2018. We need to do better on social care. www.gov.uk/government/speeches/we-need-to-do-better-on-social-care. (21.11.2018).
- Kõre, J.** (2018). Vaeste hoolekandest sotsiaalhoolekandeks. *Sotsiaaltöö*, 20. aasta juubeli erinumber, 42–49.
- Sootla, G.** (2018). Haldusreform 2017. Artiklikogumik, toimetaja S. Valner, 301–320.
<https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2018/07/haldusreform-2017.pdf> (30.08.2018).
- Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016–2020** (2016). Koondaruande koostaja A. Rasu.
www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalteenuste_ja_toetuste_andmeregister_STAR/Lisainfo/mak_analuus_toimetatud.pdf (30.08.2018).
- Swianiewicz, P., Gendźwił, A., Zardi, A.** (2017). Territorial reforms in Europe: Does size matter? Territorial Amalgamation Toolkit. Tools for Local and Central Authorities.
<https://rm.coe.int/territorial-reforms-in-europe-does-size-matter-territorial-amalgamation/168076cf16> (30.08.2018).